Embolisatie van de vena spermatica (afsluiten spatader van de teelbal)

Uw behandelend arts heeft in overleg met u een embolisatie van de vena spermatica aangevraagd. Dit betekent dat er sprake is van een soort spatader van de teelbal. De ader die het bloed van de teelbal afvoert, is dan kronkelig en te wijd. Dit noemen we een ‘varicocèle’. De ader die het bloed van de teelbal afvoert, heet vena spermatica. Een varicocèle kan de vruchtbaarheid verminderen en pijn en een zwaar gevoel in de balzak geven. Met een embolisatie van de vena spermatica sluiten we deze ader af. De klachten zullen hierdoor verminderen of verdwijnen.

We doen deze behandeling dus om de spataderen rondom de teelbal af te sluiten en te laten krimpen.

De behandeling vindt plaats op een speciale röntgenkamer. De interventieradioloog voert de behandeling uit. Een radioloog in opleiding of een radiodiagnostisch laborant helpen de radioloog tijdens deze behandeling.

Overgevoeligheid

Bent u astmatisch of allergisch? Meld dit dan vóór de behandeling. Heeft u eerder een onderzoek met contrastmiddel gehad en hierbij problemen als jeuk of kortademigheid ervaren? Meld u dit dan duidelijk bij de laborant en de interventieradioloog.

Voorbereiding

De brancardier brengt u in bed naar de interventiekamer. Deze kamer maakt deel uit van het operatiecomplex.

Hoe gaat de behandeling?

Tijdens de behandeling ligt u op uw rug op de behandeltafel. Wij maken uw huid schoon met chloorhexidine. Daarna krijgt u een blauw steriel laken over u heen. Het is belangrijk dat u uw armen onder het laken houdt. De medewerkers in de kamer dragen steriele kleding. Denk hierbij aan een mondmasker, een muts en een jas.

De ingreep kan zowel via de lies als via de halsader uitgevoerd worden. De radioloog verdooft uw huid. Daarna prikt de radioloog met een speciale naald in de ader. Door deze naald brengt de radioloog een soepel metalen draadje in de ader. Dit is niet pijnlijk. De radioloog verwijdert de naald. Hij/zij schuift nu over het metalen draadje een kort hol buisje. De radioloog brengt via het buisje een katheter in uw lichaam. Onder röntgendoorlichting schuiven we de katheter op naar het bloedvat dat verantwoordelijk is voor de spataders.

Als de katheter goed ligt, maken we röntgenfoto’s. Om de bloedvaten te kunnen zien, gebruiken we contrastvloeistof. Dit kan een warm gevoel geven.

Als we de goede ader hebben gevonden is, spuiten we kleine metalen draadjes met microvezels in het bloedvat. Hierdoor sluiten de spataders af. Als we tevreden zijn over het resultaat, is de behandeling

klaar. De radioloog verwijdert de katheter. Hij/zij drukt daarna het prikgaatje stevig dicht. Daarna helpen wij u weer in uw bed.

Hoelang duurt de behandeling?

De behandeling duurt ongeveer 45 tot 60 minuten.

Na het onderzoek

U gaat weer terug naar uw afdeling. U moet 1 uur in bed blijven. De verpleegkundige komt regelmatig bij u kijken. Hij/zij voert dan controles uit. Denk hierbij aan uw bloeddruk meten, uw temperatuur meten en het wondje controleren.

U mag na de behandeling weer gewoon eten en drinken zoals u gewend bent. Het is belangrijk dat u voldoende drinkt (1,5 tot 2 liter). De contrastvloeistof haalt vocht in het lichaam weg. Het is daarom belangrijk dat u dit vochtverlies aanvult. Als er geen problemen optreden, mag u na een paar uur naar huis. U krijgt een recept mee voor pijnstillers.

Na de behandeling duurt het een paar dagen voordat de spataderen krimpen. Soms duurt dit langer.

Risico's

Geen enkel 'invasief' onderzoek is zonder risico's. Zo kunnen ook tijdens een embolisatie bijwerkingen optreden:

- We gebruiken contrastmiddel. Uw nierfunctie kan hierdoor tijdelijk lager zijn.
- Na het onderzoek kan een blauwe plek ontstaan in de lies. Dit is vervelend, maar deze trekt na een tijd vanzelf weer weg.
- Er kan een klontje ontstaan in de ader van de lies waarin we hebben geprikt. Dit heet een trombosebeen. De kans hierop is klein.

Heeft u vragen?

Bel dan met de Afdeling Radiologie:

- van maandag tot en met vrijdag
- tussen 8.30 - 16.30 uur
- telefoon: (070) 210 5169

U kunt ook contact opnemen met uw behandelend arts.

Voor het onderzoeken nemen de laboranten de tijd om met u door te nemen wat er gaat gebeuren. Ook bij hen kunt u uw nog vragen stellen.

Wat vindt u van deze patiënteninformatie?

Wij horen graag uw mening over deze folder. Wilt u na het lezen enkele vragen beantwoorden? U vindt de vragen via deze link: https://folders.hagaziekenhuis.nl/2228. Dank u wel.

Spreekt u geen of slecht Nederlands?

De informatie in deze folder is belangrijk voor u. Als u moeite heeft met de Nederlandse taal, zorg dan dat u deze folder samen met iemand leest die de informatie voor u vertaalt of uitlegt.

Do you speak Dutch poorly or not at all?

This brochure contains information that is important for you. If you have difficulty understanding Dutch, please read this brochure with someone who can translate or explain the information to you.

Czy Państwa znajomość języka niderlandzkiego jest żadna lub słaba?

Informacje zawarte w tym folderze są ważne dla Państwa. Jeśli język niderlandzki sprawia Państwu trudność, postarajcie się przeczytać informacje zawarte w tym folderze z kimś, kto może Państwu je przetłumaczyć lub objaśnić.

Hollandaca dilini hiç konuşamıyor musunuz veya kötü mü konuşuyorsunuz?

Bu broşürdeki bilgi sizin için önemlidir. Hollandaca dilinde zorlanıyorsanız, bu broşürü, size tercüme edecek ya da açıklayacak biriyle birlikte okuyun.

إذا كنتم لا تتحدثون اللغة الهولندية أو تتحدثونها بشكل سيء إن المعلومات الموجودة في هذا المنشور مهمة بالنسبة لكم. إذا كانت لديكم صعوبة في اللغة الهولندية، فاحرصوا عندئذ على قراءة هذا المنشور مع شخص يترجم المعلومات أو يشرحها لكم.

150106062025